

Dotknij *i nie myj*

60–80% pacjentów osiąga istotną redukcję. Mózg uczy się, że lęk opada SAM — bez mycia. Najsilniejsza interwencja w OCD kontaminacyjnym.

CZAS: 30 min ekspozycji + 60 min powstrzymania mycia 4–5 razy w tygodniu, 8–12 tygodni

ŹRÓDŁO: Foa i wsp. (2005, RCT $d=1,12$); Abramowitz i wsp. (2003); Foa i Kozak (1986); NICE CG31

JAK UŻYWAĆ

Zbuduj **hierarchię 7-stopniową**: od dotknięcia klamki (SUDS 25) do jedzenia palcami bez mycia (SUDS 85). Każdy krok: **dotknij + nie myj min. 60 min**, SUDS co 10 min. Powtarzaj aż SUDS ≤ 30 . Awansuj wyżej. Wariuj konteksty (dom, praca, park). Łącz z powstrzymaniem reakcji w warstwie mentalnej.

DLACZEGO TO DZIAŁA

ERP kontaminacyjne (Foa i wsp., 2005, RCT, $d = 1,12$) to **najsukuteczniejsza terapia OCD kontaminacyjnego**: 60–80% pacjentów osiąga klinicznie istotną poprawę (Abramowitz i wsp., 2003). Mechanizm: **mycie i unikanie utrwalają lęk**. Pacjent myje ręce 40× dziennie, unika klamek, ławek, podłóg. Każde mycie obniża lęk na sekundy i wzmacnia obsesję długoterminowo. Mózg uczy się: „**lęk znika TYLKO po umyciu**” — co jest fałszem; lęk **opada sam**, jeśli się go nie neutralizuje. Foa i Kozak (1986): *emocjonalne przetwarzanie* + nowe uczenie korygujące. Wariacja kontekstów (Craske 2014) generalizuje uczenie. NICE CG31 (2005): leczenie *pierwszego wyboru*.

01 ◎ Hierarchia kontaminacyjna — przykład 7-stopniowy

LP.	SYTUACJA	SUDS <i>bez mycia</i>	CZAS RP <i>min</i>
1	Dotknięcie klamki drzwi wejściowych	25	60
2	Dotknięcie ławki w parku	35	60
3	Uściśnięcie dłoni obcej osoby	45	60
4	Dotknięcie podłogi w domu	55	60
5	Dotknięcie podłogi w toalecie publicznej	65	60
6	Dotknięcie zewnętrznej strony kosza	75	60
7	Jedzenie palcami po dotknięciu klamki	85	60

Każdy krok: dotknij wyznaczonego obiektu + *nie myj rąk przez minimum 60 minut*. Monitoruj SUDS co 10 min. Powtarzaj kilkakrotnie, aż SUDS spadnie do ≤ 30 . Awansuj.

02 Przykład kliniczny — Monika

Pacjentka: Monika, 34 lata. Mycie rąk 40 razy dziennie, pęknięta skóra, izolacja społeczna.

Tydzień 1: klamka + 60 min bez mycia. SUDS: 70 → 45 → 25 (po 60 min).

Tydzień 4: podłoga w toalecie publicznej. SUDS: 80 → 50 → 30.

Tydzień 8: jedzenie palcami bez mycia. SUDS: 85 → 40 → 20.

Po 12 sesjach: mycie 4 razy dziennie. Skóra zagojona. Wróciła do pracy biurowej.

03 Twoja hierarchia kontaminacyjna

LP.	MOJA SYTUACJA KONTAMINACYJNA — KONKRETNIE	SUDS bez mycia	LICZBA powtórzeń
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

04 Kluczowe zasady ERP kontaminacyjnego

1 • NIE „NIE BÓJ SIĘ”

ERP **nie mówi** „nie bój się”. Mówi: „*bój się i obserwuj, co się stanie z lękiem*”. Lęk jest tu, ekspozycja go nie odwołuje.

2 • 60 MIN MINIMUM

Mniej niż 60 min — SUDS nie zdąży opaść. **Mózg nie dostanie** sygnału: „lęk spada sam”. Kluczowy minimalny czas.

3 • BEZ „CZĘŚCIOWEGO” MYCIA

„Tylko trochę umyję” = **kompulsja**. Mózg uczy się: bezpieczeństwo z mycia. Albo pełne RP, albo nie.

4 • WARIUJ KONTEKSTY

Ta sama ekspozycja w **różnych miejscach** (dom, praca, park). Generalizuje uczenie (Craske 2014).

05 Dziennik ekspozycji kontaminacyjnej

DATA	EKSPOZYCJA — CO DOTKNAŁEM/-AM	SUDS początek → po 60 min	MYCIE T / N	WNIOSEK

Klucz: ERP kontaminacyjne jest *archetypicznym* protokołem terapii OCD — od jego skuteczności pochodzi reputacja całego ERP. Foa i wsp. (2005, RCT): **d** = 1,12. NICE CG31 (2005) i APA (2007) rekomendują jako *leczenie pierwszej linii*. Kluczowe: **60-80% pacjentów** osiąga klinicznie istotną poprawę w ciągu 12-16 tygodni. Pułapka: *częściowe mycie* („tylko trochę”). Mózg **nie uczy się** bezpieczeństwa, dopóki mycie jest jakkolwiek obecne. Albo pełne RP — albo brak postępu. ERP to *nie tortura* — to **nauka**, że lęk opada sam, bez kompulsji.